

TEMA 1.44 • CARDIOLOGÍA

Trombosis Venosa Profunda

PERFIL EUNACOM 1.011.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Trombosis Venosa Profunda (TVP)** es una patología frecuente y de alta relevancia clínica, ya que representa la principal causa del **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)**. Su sospecha clínica debe ser alta en pacientes con factores de riesgo específicos, fundamentados en la fisiopatología de la formación de trombos.

Fisiopatología: La Tríada de Virchow

Para que se produzca una trombosis venosa, generalmente deben interactuar los elementos de la **Tríada de Virchow**. La presencia de estos factores aumenta significativamente la probabilidad diagnóstica.

TABLA 1.44.1: COMPONENTE VS EJEMPLOS CLÍNICOS

COMPONENTE	EJEMPLOS CLÍNICOS
Hipercoagulabilidad	Cáncer, Lupus Eritematoso Sistémico (asociado a SAF), Síndrome Nefrótico , embarazo, puerperio y trombofilias congénitas.
Estasis Venosa	Pacientes postrados, reposo prolongado, cirugía reciente, viajes largos, insuficiencia cardíaca.
Daño Endotelial	Traumatismos, cirugías, fracturas, catéteres venosos centrales.

NOTA CLÍNICA

Las **trombofilias** pueden ser: - **Adquiridas**: Síndrome Antifosfolípido (SAF), cáncer, uso de estrógenos. - **Congénitas**: Déficit de antitrombina III, déficit de proteína C o S, Factor V de Leiden.

Cuadro Clínico

La presentación clásica de la TVP es **unilateral** (es muy raro que sea bilateral, a menos que afecte la vena cava). Los síntomas y signos cardinales incluyen:

- **Dolor**: Habitualmente localizado en la cara posterior de la pierna (pantorrilla).
- **Edema**: Aumento de volumen blando que deja fóvea (signo de la fóvea positivo).
- **Cambios de coloración**: La extremidad puede verse cianótica (azulada) o eritematosa (roja).
- **Signos de Insuficiencia Venosa**: Pueden preexistir telangiectasias, venas dilatadas o **lipodermatoesclerosis** (piel café e hiperpigmentada en la zona maleolar).

Hallazgos al Examen Físico

1. **Signo de Homans**: Dolor en la pantorrilla al realizar la dorsiflexión pasiva del pie. 2. **Empastamiento muscular**: Los músculos de la pantorrilla se palpan tensos o endurecidos. 3. **Cordón venoso palpable**: En ocasiones se puede palpar la vena trombosada como una estructura dura entre los músculos (no confundir con tromboflebitis superficial).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir la **TVP** con la **tromboflebitis superficial**. En la tromboflebitis se palpa un cordón venoso externo y superficial, habitualmente eritematoso y doloroso, pero que no compromete el sistema venoso profundo ni tiene el mismo riesgo embolígeno.

Diagnóstico Diferencial

- Existen cuadros que pueden simular perfectamente una TVP:
- **Quiste de Baker roto**: Antecedente de aumento de volumen en la fosa poplítea que, al romperse, genera dolor y edema agudo.
- **Celulitis**: Suele cursar con más fiebre y compromiso cutáneo evidente, aunque a veces son indistinguibles clínicamente.

Algoritmo Diagnóstico

El diagnóstico definitivo es imagenológico, pero la estrategia depende de la probabilidad clínica (Score de Wells).

1. Probabilidad Clínica y Dímero D

El **Dímero D** es un producto de la degradación de la fibrina. Su principal utilidad es su **alto valor predictivo negativo**.

- **¿Cuándo pedirlo?** Solo cuando hay **baja sospecha** clínica (Wells < 3) y no existen otras causas que lo eleven.
- **¿Cuándo NO pedirlo?** Si hay alta sospecha o si el paciente tiene inflamación, cirugías recientes, fracturas o celulitis, ya que estará elevado de forma inespecífica. En estos casos, se va directo a la imagen.
- **Interpretación:**
 - Si el Dímero D es **normal (< 500 ng/ml)**: Se descarta la TVP.
 - Si el Dímero D está **elevado**: No confirma TVP, se requiere realizar un Eco-Doppler.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para recordar el valor de corte del Dímero D: La letra **D** en números romanos equivale a **500**. Por lo tanto, el valor normal es menor a **500**.

2. Eco-Doppler Venoso

Es el examen de elección (**Gold Standard**). Permite visualizar la vena y demostrar la ausencia de flujo o la falta de compresibilidad de la misma debido al trombo.

3. Estudio de Trombofilias

Una vez manejado el episodio agudo, se debe evaluar si el paciente requiere un estudio de trombofilias. Esto es fundamental para decidir si la anticoagulación será temporal o de por vida.

Tratamiento

El objetivo principal del tratamiento es evitar la progresión del trombo y prevenir el **Tromboembolismo Pulmonar**.

- **Anticoagulación**: Es el pilar terapéutico.
- - **Inicial**: Se puede usar Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM), Heparina No Fraccionada o Anticoagulantes Orales Directos (DOACs/NACOs) como el Rivaroxabán o Apixabán.
- - **Embarazo**: El tratamiento de elección es siempre la **HBPM**, ya que no atraviesa la placenta.
- **Duración**:
 - Mínimo **3 meses**.
 - En casos de factores de riesgo persistentes o trombofilias, puede extenderse a 6 meses o ser permanente.
- **Medidas Generales**: Reposo relativo inicial para evitar el desprendimiento del trombo en los primeros días.

EUNACOM CRITERIOS

Por regla general, la TVP **no se tromboliza ni se opera** (trombectomía). El manejo estándar es exclusivamente la anticoagulación.

Complicación Grave: Phlegmasia Cerulea Dolens

- Es una forma masiva y grave de TVP que constituye una urgencia vascular.
- **Fisiopatología**: El edema es tan masivo que genera un vasoespasmo arterial secundario.
- **Clínica**: Dolor isquémico, cianosis intensa y riesgo de necrosis de la extremidad.

- **Tratamiento:** En este caso excepcional, se requiere un manejo agresivo con **trombolisis** (venosa o por catéter) o **trombectomía** para restablecer el flujo.

NOTA CLÍNICA

La **Phlegmasia Cerulea Dolens** es la única excepción donde la anticoagulación sola no es suficiente y se requiere intervención para salvar la extremidad.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 45 años, postoperada de histerectomía hace 7 días, consulta por aumento de volumen, dolor y empastamiento de pantorrilla izquierda. Signo de Homans positivo. Score de Wells para TVP: 3 puntos (probabilidad alta)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

TVP proximal post-quirúrgica. Con probabilidad clínica alta (Wells ≥ 3), se solicita directamente Ecografía Doppler venosa (NO Dímero D, que solo sirve para descartar en probabilidad baja). Tratamiento: Anticoagulación con HBPM (Enoxaparina 1 mg/kg c/12h) seguida de ACODs por mínimo 3 meses. El Dímero D se utiliza solo cuando la probabilidad clínica es BAJA para descartar TVP.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La tríada de Virchow: estasis, daño endotelial e hipercoagulabilidad
- Las TVP proximales tienen mayor riesgo de TEP que las distales
- Score de Wells estratifica la probabilidad clínica de TVP
- Dímero D negativo con probabilidad baja descarta TVP
- La ecografía Doppler venosa es el examen confirmatorio de elección
- DOACs (rivaroxabán, apixabán) son primera línea de tratamiento
- TVP provocada: 3 meses; no provocada: evaluar anticoagulación extendida
- Filtro de VCI solo con contraindicación absoluta de anticoagulación

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA)**PREGUNTA 1**

Mujer de 35 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por dolor y edema unilateral de pierna izquierda de 3 días. Diferencia de perímetro de pantorrilla de 4 cm. Score de Wells alto. ¿Cuál es el examen confirmatorio?

- A) Dímero D
- B) Ecografía Doppler venosa
- C) Angio-TAC de extremidades
- D) Venografía convencional
- E) RMN venosa

PREGUNTA 2

¿En cuál situación el dímero D negativo descarta TVP?

- A) En cualquier paciente independiente de la probabilidad clínica
- B) En paciente con probabilidad clínica baja por score de Wells
- C) En pacientes con cáncer activo
- D) En pacientes post-quirúrgicos
- E) En embarazadas

PREGUNTA 3

Paciente con TVP proximal provocada por cirugía de rodilla hace 2 semanas. ¿Cuál es la duración recomendada de anticoagulación?

- A) 1 mes
- B) 3 meses
- C) 6 meses
- D) De por vida
- E) Solo durante la hospitalización

RESUMEN: TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

La trombosis venosa profunda es la formación de un trombo en las venas profundas, principalmente de las extremidades inferiores. La tríada de Virchow describe los tres factores predisponentes: estasis venosa, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Las TVP proximales (poplítea, femoral, ilíaca) tienen mayor riesgo de TEP que las distales. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica estratificada con el score de Wells para TVP. Clínicamente se presenta con dolor, edema unilateral, calor y empastamiento de la pantorrilla. El dímero D tiene alto valor predictivo negativo: un dímero D negativo con probabilidad baja descarta TVP. La ecografía Doppler venosa de extremidades inferiores es el examen confirmatorio de elección. El tratamiento es anticoagulación. Los anticoagulantes orales directos (DOACs) como rivaroxabán o apixabán son primera línea por su facilidad de uso. La alternativa es heparina de bajo peso molecular seguida de warfarina. La duración mínima es 3 meses. TVP provocada por factor transitorio: 3 meses. TVP no provocada o recurrente: anticoagulación extendida. Las medias de compresión elástica ya no se recomiendan de rutina para prevenir síndrome post-trombótico.